Poder Judiciário da Paraíba
Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde Suplementar
Gabinete Virtual

SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por ARTHUR JUSTINO CRUZ ARAUJO, neste ato representado por JOCELMA JUSTINO CRUZ ARAÚJO, em face da UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Alega a parte autora que celebrou contrato de prestação de serviços de saúde com a promovida, encontrando-se adimplente com todas as obrigações contratuais. Narra que foi diagnosticado com Esofagite Eosinofílica, doença inflamatória crônica do esôfago, e tentou tratamentos convencionais, como Pantoprazol, dietas de eliminação e corticosteroides deglutidos, mas sua condição clínica piorou. Afirma que, atualmente, apresenta sintomas graves como dor ao engolir, engasgos frequentes e a sensação de que a comida fica presa, o que impacta sua qualidade de vida.
Devido à gravidade do caso, a médica do autor prescreveu com urgência o tratamento imunobiológico com **Dupixent (Dupilumabe) 300mg a cada oito dias, por um período inicial de 2 anos**. A Unimed, contudo, negou a cobertura, alegando que o medicamento não atende à Diretriz de Utilização nº 65 da ANS para esofagite eosinofílica. Alega o autor que, embora o Dupixent não conste no rol da ANS para essa indicação, a ANVISA aprovou seu uso para a Esofagite Eosinofílica em pacientes a partir de 12 anos.
Sustenta a ilegalidade da negativa, por afrontar as disposições da Lei nº 9.656/98 e da Lei nº 14.454/2022, que asseguram a cobertura de procedimentos e tratamentos prescritos pelo médico assistente, ainda que não constem do rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia e necessidade clínica para o caso concreto.
Requereu, em caráter liminar, a obrigação de fazer para autorização imediata do tratamento, sob pena de multa, e, ao final, a confirmação da tutela com a condenação da ré ao custeio do medicamento e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa indevida.
Após a citação, a promovida apresentou contestação na qual sustenta, em síntese, que a negativa de cobertura do medicamento decorreu do fato de o tratamento não constar do rol de procedimentos da ANS, cuja natureza seria taxativa à luz dos precedentes do STJ. Argumenta, ainda, a inconstitucionalidade da Lei nº 14.454/2022. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.
Tutela de urgência deferida (ID. 101564678). Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça manteve a tutela provisória deferida (ID. 108401271).
Parecer do Ministério Público (ID. 113195262).
Em seguida, os autos foram conclusos.
É o breve relatório.

Passo a decidir.

Preliminarmente - Da impugnação ao valor da causa

A preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pela parte ré merece acolhimento parcial.

Conforme alegado, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 509.200,00, correspondente ao custo total estimado do tratamento com Dupixent (Dupilumabe) por dois anos. O réu argumenta que o valor foi fixado de forma aleatória e sem base legal, devendo ser reajustado com base na tabela de procedimentos da operadora.

O artigo 292 do Código de Processo Civil estabelece critérios para a fixação do valor da causa. Em seu §2º, a lei dispõe que, em ações que envolvam prestações vincendas, o valor deve ser correspondente a uma prestação anual, se a obrigação tiver duração superior a um ano. No caso em tela, o tratamento foi prescrito para um período inicial de 2 anos, o que se enquadra na regra legal.

Assim, o valor atribuído à causa deve ser revisto para corresponder a um ano de tratamento, e não dois. A estimativa apresentada na própria petição inicial indica que o custo anual do tratamento é de R$ 249.600,00.

Diante do exposto, acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa para determinar que este seja fixado em R$ 249.600,00, que corresponde ao valor de 1 (um) ano de tratamento.

Do mérito

A parte autora pretende, com a presente ação, o custeio, pelo plano de saúde demandado, da realização de tratamento com Dupixent (Dupilumabe), para fins de tratar um quadro grave de Esofagite Eosinofílica. Almeja, ainda, a fixação de danos morais, supostamente experimentados, em decorrência da negativa do promovido em autorizar a realização do referido tratamento.

Constata-se, pela análise dos autos, que a relação jurídica existente entre as partes traduz-se em relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, verifico a **presença de laudo médico comprovando que a promovente necessita do mencionado medicamento, em razão do quadro grave de Esofagite Eosinofílica** (ID. 98894047 e 100072321), sendo certo que a paciente já passou por inúmeros tratamentos anteriores, todos sem sucesso. Em consonância, verifico que a ANVISA aprovou, em 03/04/2023, o uso do Dupixent para Esofagite Eosinofílica, conforme documento de ID. 98896003 - Pág. 01, que assim dispõe: "*DUPIXENT é indicado para o tratamento de esofagite eosinofílica (EEo) em pacientes a partir de 12 anos de idade com peso corporal igual ou superior a 40 Kg (...)".*

Apesar disso, a promovida negou a cobertura do referido tratamento, ao argumento de que o procedimento não tem cobertura contratual nem legal, não sendo aceito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.

Destaco as inúmeras tentativas de cura, através de tratamentos diversos, realizadas pela parte autora e a equipe que o acompanha, conforme o laudo anexo (ID. 98894047): "(...) *Arthur apresentou os primeiros sintomas de Esofagite Eosinofílica em 2021, com progressiva piora apesar de tratamentos extensivos, incluindo Pantoprazol, dietas de eliminação, e corticosteroide deglutido (Flixotide)".*

Dessa forma, restou incontroverso o quadro de saúde apresentado pela parte autora, onde o risco de agravamento da enfermidade é iminente, de modo que o tratamento é considerado urgente ou emergente, sendo obrigatória a cobertura.

A alegação da defesa, de que o medicamento não consta do rol de coberturas obrigatórias estabelecido pela ANS não merece guarida, pois o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de maneira que a operadora deve arcar com os procedimentos necessários e urgentes indicados pelo médico, que se mostrem eficientes à cura.

Destaco, ainda, que, recentemente, foi sancionado o projeto de lei que acaba com a taxatividade do rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A norma tornou a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde.

Dessa forma, é atribuição dos médicos a competência para decidir sobre o tratamento adequado aos usuários dos respectivos contratos de prestação de serviços médico-hospitalares.

Mister que se acaso “eventualmente” o contrato entabulado entre as partes vede expressamente a cobertura para o tratamento solicitado, tendo como justificativa que “o procedimento não está previsto pela ANS”, esta situação não é suficiente para a negativa da autorização solicitada, pois o tratamento a ser dado é o adequado à enfermidade que a parte possui.

Logo, reconheço o dever da promovida na obrigação de fazer consistente no custeio do exame narrado na inicial, independentemente de qualquer ônus para a parte requerente.

Quanto ao argumento de inconstitucionalidade da Lei 14.454/2022, não merece acolhimento. Ela foi criada seguindo todas as etapas do processo legislativo e está alinhada com os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da saúde como um direito essencial, conforme

previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988. Portanto, não existe qualquer falha formal ou material que possa invalidá-la, e sua aplicação ao caso específico é justificada.

Dessa forma, a tese sustentada pela parte ré não se mostra consistente, não havendo respaldo para a exclusão do fornecimento do medicamento.

Dos danos morais

Sobre a matéria em exame, se faz oportuno destacar acórdãos proferidos pelo E. Tribunal de Justiça da Paraíba, cujas ementas seguem, respectivamente, a seguir transcritas:

> *Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Gabinete 13 A C Ó R D Ã O DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Hapvida Assistência Médica LTDA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por Paulo Jorge da Conceição Fernandes, sucedido por Sabrina Kelly Dantas Bezerra. O plano de saúde recusou o fornecimento dos medicamentos prescritos para tratamento de Mesotelioma Pleural sob a justificativa de ausência de previsão no rol da ANS. A sentença condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a herdeira tem legitimidade para prosseguir com a ação indenizatória; e (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento de medicamento pelo plano de saúde, com base no rol da ANS, configura abusividade ensejadora de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros com o falecimento do titular, conforme Súmula 642 do STJ, conferindo-lhes legitimidade para prosseguir com a ação indenizatória. 4. A relação contratual entre consumidor e plano de saúde deve respeitar o Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que cláusulas limitativas de cobertura devem ser expressas e de fácil compreensão. 5. A jurisprudência do STJ reconhece o rol da ANS como meramente exemplificativo, admitindo a obrigação do plano de saúde de custear tratamentos prescritos pelo médico quando necessários à preservação da saúde e qualidade de vida do paciente. 6. A recusa injustificada de cobertura do tratamento essencial prescrito ao paciente configura ato ilícito, agravando sua situação de aflição psicológica e sofrimento, o que enseja indenização por danos morais. 7. O valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direito à indenização por danos morais transmite-se aos herdeiros com o falecimento do titular, conferindo-lhes legitimidade para prosseguir com a ação. 2. O rol da ANS possui natureza meramente exemplificativa, não podendo ser utilizado como fundamento exclusivo para a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito por médico. 3. A recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde, quando há indicação médica, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54, § 4º; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 642; TJ-PA, Apelação Cível 08332619120218140301; TJSP, Apelação Cível 1030733-20.2018.8.26.0577. (0800513-20.2021.8.15.2001, Rel. Gabinete 13 - Desembargador (Vago), APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 03/07/2025)*

> *APELAÇÃO CÍVEL. GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DO MATERIAL MÉDICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ILEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE QUALIFICADO COMO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. 1.285.483-PB DE 16/O8/2016). AFASTAMENTO DA NORMA CONSUMERISTA QUE NÃO DESCONSTITUI A NATUREZA JURÍDICA DE CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI*

9.656/1998. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE (ART. 423 DO CC/02). COBERTURA DE ENFERMIDADE QUE EM DECORRÊNCIA LÓGICA ABRANGE TODOS OS PROCEDIMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O ÊXITO DA SAÚDE DO SEGURADO. ***HERMENÊUTICA FINALISTA DO PACTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.*** *PEDIDO DE REDUÇÃO. QUANTUM FIXADO DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. - "Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão e seus filiados, na hipótese em que firmado contrato de cobertura médico-hospitalar." (REsp 1.285.483-PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/6/2016, DJe 16/8/2016) - O fato do atual entendimento do Tribunal Cidadão ser pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos Plano (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014328620148152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO, j. em 02-04-2019).*

Ora, como se não bastassem os sofrimentos advindos da própria enfermidade, suportar uma desarrazoada negativa de cobertura do plano de saúde é motivo mais do que suficiente para desestabilizar a parte, ensejando a reparação pelos danos morais suportados.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora não demonstrou agravamento em seu quadro de saúde em decorrência da demora no fornecimento do medicamento. Todavia, houve recusa indevida no fornecimento do remédio, fato que motivou a necessidade de ação judicial para reparação do ilícito. Nesse contexto, à luz da **teoria do desvio produtivo**, entendo que a situação gera direito à indenização, uma vez que a parte autora foi compelida a despender tempo, esforço e recursos para ver garantido seu direito.

Reconhecida a existência do dano moral, cumpre fixar o quantum indenizatório, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a finalidade de compensar o dano sofrido.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem adotando, há algum tempo, o método bifásico de fixação de danos morais. Neste método, inicialmente estabelece-se um valor básico para a reparação, considerando o interesse jurídico lesado e um grupo de precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes. Depois, na segunda etapa, verificam-se as circunstâncias do caso em análise e suas peculiaridades, a fim de fixar, em definitivo, a indenização de forma equitativa.

Assim, observados os parâmetros acima citados, tem-se por adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como forma de compensação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, **julgo PROCEDENTES** os pedidos formulados pela parte autora, para:

a) CONDENAR a UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na obrigação de fazer, consistente no custeio da medicação **Dupixent (Dupilumabe) 300mg**, observadas as regras estabelecidas contratualmente acerca da co-participação do usuário, confirmando a tutela provisória deferida;

b) CONDENAR a UNIMED CAMPINA GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento, em favor da parte autora, de indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento dos danos morais nesta sentença, conforme a Súmula 362 do STJ; e juros de mora pela taxa SELIC, estes a partir da citação (Artigo 405 do Código Civil), observada a dedução da variação do IPCA, conforme art. 406 do Código Civil.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em caso de recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões, no prazo de 15 dias, após, remetam-se ao Tribunal.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido em 15 dias, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

João Pessoa (PB), datado/assinado eletronicamente.

Philippe Guimarães Padilha Vilar

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: PHILIPPE GUIMARAES PADILHA VILAR
18/09/2025 23:58:58
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 123306812

25091823585840100000 1

IMPRIMIR GERAR PDF